★★★颈腰椎退行性病（0~4题）

概述

颈椎 1、2 无椎间盘，颈椎 3~7 有钩椎 /Luschka 关节（2012）
椎间盘结构：软骨终板、髓核、纤维环（2021）

椎间盘易向侧后方突出
- 第 m-n 椎间盘压迫第 n 神经根
- 刺激或压迫神经根致疼痛：机械性压迫、化学性刺激、自身免疫性（2015）

影像（2008、2009、2010、2015、2019）
- X 线：生理曲度异常、骨质增生、钙化、椎间隙狭窄、椎间盘突出间隙不等宽等
- CT：上述 X 线内容 + 观察椎间盘，但不能清楚观察神经和脊髓等受压情况
- MRI：上述 CT 内容，清楚观察神经和脊髓等受压情况

颈椎病

（2009、2011、2013、2014、2015、2016、2017、2023、2024）

	表现	治疗
神经根型（最常见）	颈肩痛 + 上肢放射痛，上肢感觉障碍（麻木）、运动障碍（无力） Eaton 征、Spurling 征“eason”	首选保守 （按摩、颌枕带牵引等）
脊髓型（最严重）	持物不稳、踩棉花感“飘”，四肢感觉、运动障碍，二便障碍 Hoffmann 征、Babinski 征“哈巴儿”	急诊手术 禁止按摩、颌枕带牵引
交感神经型	交感神经兴奋（心悸、出汗）或抑制的表现（心动过缓、血压↓），症状多体征少	首选保守
椎动脉型	猝倒、眩晕、视物模糊	首选保守
食管型	吞咽困难	首选保守

损伤平面判断

	C5	C5-6	C6-7	C8
运动障碍	肩、上臂外展	屈肘	伸肘	屈指“你过来啊”
感觉障碍	肩、上臂外	前臂外、1 指（C6）	3 指（C7）	5 指、前臂内
深反射障碍		肱二头肌、桡骨膜	肱三头肌	